Leer el informe del sensor (AGP)

Cinco pasos · tiempo en rango

El AGP resume cuándo y con qué frecuencia aparecen bajadas o subidas. Empieza por la seguridad y después busca patrones que se repitan; evita ajustar todo a partir de un día aislado.

- 1. Calidad: revisa un período representativo, habitualmente 14 días, con al menos 70 % de datos. Anota enfermedad, corticoides, cambios de rutina y huecos de registro.
- 2. Bajadas primero: localiza tiempo bajo 70 y bajo 54 mg/dL, horarios y posibles desencadenantes.
- 3. Tiempo en rango (TIR): pregunta cuánto tiempo pasa entre 70 y 180 mg/dL. Un 70 % equivale a unas 16 h 48 min al día; es un objetivo habitual, no un requisito para todos.
- 4. Variabilidad: un coeficiente de variación (CV) de 36 % o menos es una referencia frecuente. El GMI es una estimación del control a partir del sensor y puede diferir de la HbA1c de laboratorio.
- 5. Plan compartido: cruza los patrones con comidas, insulina, ejercicio y sueño. Acuerda un cambio concreto y un momento de revisión.

Referencia	Mayoría de adultos no embarazados
TIR 70-180 mg/dL	>70 %
Tiempo <70 mg/dL	<4 %
Tiempo <54 mg/dL	<1 %
Tiempo >180 mg/dL	<25 %
Tiempo >250 mg/dL	<5 %

Objetivos individualizados. En mayores con salud compleja/intermedia suele priorizarse tiempo <70 mg/dL inferior al 1 % y TIR de al menos 50 %. Embarazo y otras situaciones necesitan rangos propios.

En LibreView, comprueba que el sensor esté vinculado a la cuenta correcta y comparte datos con el centro con consentimiento. La nube no garantiza vigilancia permanente ni sustituye la atención ante síntomas urgentes.

Fuentes

ADA, métricas de monitorización, 2026 · Consenso internacional sobre tiempo en rango, 2019 · Abbott, guías LibreView para pacientes y profesionales